

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Aliskiren 150mg, 300mg (라실레즈정 150mg, 300mg, 한국노바티스)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 라실레즈정 150mg : aliskiren hemifumarate (aliskiren으로서) 150mg
- 라실레즈정 300mg : aliskiren hemifumarate (aliskiren으로서) 300mg

☐ 효능 효과 :

- 본태성 고혈압

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2008년 제10차 약제급여평가위원회 : 2008년 8월 22일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 1차 : 2008년 7월 21일
2차 : 2008년 8월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “본태성 고혈압”에 사용하는 새로운 약물작용 기전(renin inhibitor)의 약제로, 비교약제인 ARB(angiotensin II receptor antagonist)와 비교시 임상적으로 비열등하고 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “본태성 고혈압”에 허가받은 약제로, 대상질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 Angiotensin II receptor antagonist 계열이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾에 rennin-angiotensin계의 첫 번째 단계인 renin을 직접 억제하여 angiotensinogen의 연쇄반응을 막으며, 전체 RAAS(Renin-angiotensin-aldosterone system)의 활성화를 막아 혈압강하 작용을 하는 약제로 언급하고 있으며, 지침의 표준치료에서 신청품에 대한 언급은 없음.²⁾
- 신청품 150mg과 단독비교시 irbesartan 150mg, losartan 100mg, valsartan 160mg의 sitting DBP나 SBP에 통계적으로 유의한 차이는 없었으며,³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ ramipril 5mg과의 비교시험⁷⁾에서 확장기 혈압강하 효과가 비열등하였고, 약과 관련된 특이적인 이상반응은 보고되지 않음.
 - 최종 안전성 평가에서 전체 이상반응은 aliskiren군과 ramipril군이 유사(61.3% vs. 60.4%)하였으나, ramipril의 기침 발생률이 높았음.(9.5% vs 4.1%)
 - 제약사에서 주장하는 [REDACTED] 자료원은 포스터 발표자료로 근거수준이 낮음.
- valsartan 320mg과의 병용투여 시 각 약제 단독사용에 비해 유의하게 확장기혈압을 낮추었으며, 내약성은 유사하였음.⁸⁾
- RAAS에 작용하는 약제로, ARB나 ACEI(Angiotensin-converting enzyme inhibitor)에 비해 PRA(plasma renin activity)의 감소작용에 대한 장기간 자료가 부재함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 RAAS에 작용하는 약제로, 동 system에 작용하는 ARB나 ACEI가 대체가능하며⁹⁾, ACEI의 마른 기침 등 내약성을 개선시킨 ARB에 대한 임상선택 경향, 사용비중¹⁰⁾을 고려하여 ARB¹¹⁾를 비교약제로 선정함.

- 임상지침¹²⁾에서 항고혈압제를 기전별로 사용하는 점을 고려하여 기전별로 선정함.
- 투약비용 비교시, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 비교약제인 ARB의 가중일일투약비용인 ■■■원보다 저가임.
- 제출된 경제성 평가자료(■■■) 검토 결과, 경증 또는 중증도의 고혈압 환자에서 신청품은 valsartan 160mg(ARB)에 비열등하고 소요금액은 저가로, 비교대안에 비해 비용효과적임.

○ 재정 영향

- 신청품 투여 대상 환자수¹³⁾는 1차년도(2009년)에 ■■■명에서 3차년도(2011년)에 ■■■명으로 증가할 것으로 예상됨.
- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾은 1차년도에 약 ■■원 및 3차년도에 약 ■■원이 되고, ARB, ACEI의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■원, 3차년도에 약 ■■원 증가될 것으로 예상됨¹⁵⁾.
- ARB의 사용비중이 매년 증가하고 있으므로, ARB, ACEI의 대체에 의한 재정증가액은 감소 할 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 미국, 독일, 스위스, 영국에 등재됨.

REFERENCE

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th
- 2) 우리나라의 고혈압 진료지침 (대한고혈압학회, 2004), 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
- 3) Nussberger J, et al, Plasma renin and the antihypertensive effect of the orally active renin inhibitor aliskiren in clinical hypertension, Int J Clin Pract, 2007 Sep;61(9):1461-8.
- 4) Gradman, et al, Aliskiren, a Novel Orally Effective Renin Inhibitor, Provides Dose-Dependent Antihypertensive Efficacy and Placebo-Like Tolerability in Hypertensive Patients, Circulation. 2005 Mar 1;111(8):1012-8
- 5) Stanton et al., Blood Pressure Lowering in Essential Hypertension With an Oral Renin Inhibitor, Aliskiren, Hypertension. 2003;42:1137-1143
- 6) Oparil et al, Efficacy and safety of combined use of aliskiren and valsartan in patients with hypertension: a randomised, double-blind trial, Lancet 2007; 370: 221-29
- 7) 필요시 hydrochlorothiazide와 병용, Andersen et al, Comparative efficacy and safety of aliskiren, an oral direct renin inhibitor, and ramipril in hypertension: a 6-month, randomized, double-blind trial, Journal of Hypertension 2008, 26:589-599
- 8) 5)번 문헌에서 신청품과 valsartan 고용량의 병용요법에 대한 단독요법 대비 혈압강하효과
- 9) 대한고혈압학회(■), 대한심장학회(■), 대한가정의학회(■), 대한신장학회(■)
- 10) 2007년 EDI 청구량(상병■) 비율 ARB : ACEI = ■% : ■%
- 11) losartan, eprosartan, valsartan, irbesartan, candesartan, telmisartan, olmesartan
- 12) 우리나라의 고혈압 진료지침 (대한고혈압학회, 2004), 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
- 13) 2005년~2007년 EDI로 본태성고혈압(■)에 ARB를 청구한 환자수의 이동평균을 적용하여 추정한 환자수
- 14) 제약사 예상사용량 × 신청금액
- 15) 재정증감액 = {(제약사예상환자수 × 신청품의 150mg기준 치료기간 당 투약비용(■원) + (실무예측환자수 - 제약사예상환자수) × 대체약제의 치료기간 당 가중 소요비용(■원)} - {실무 예측 환자수¹²⁾ × 대체약제의 치료기간 당 가중 소요비용(■원)}